



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : هند فاروق محمد سعداوي

العنوان : --

الحي / المدينة : المعادي

المحافظة : القاهرة

تاريخ تسجيل الإستمارة : 10-10-2026

رقم البطاقة : 27701150101981 رقم التليفون : 01285242907

العمر (تاريخ الميلاد) : 15-01-1977 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل :- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات أو أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

المقرر بما فيه (.....) التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الأبحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : التوقيع :

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة ومدير المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

..... د/..... د/..... د/..... د/.....

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى : قسم :
جهة العلاج : نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: هند فاروق محمد سعادوي National ID: 27701150101981	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



هند
فاروق محمد سعودي
٢٠٥٥ مدينة المعراج
المعادي - القاهرة

١١٧٧/٠٧/٥٠ ٢٧٧٠١١٥٠١٠١٩٨١

JM2279607

على صورة
+
٣١٨٥



٢٠٢٢/٠٨/١٢ ٢٧٧٨١٥٠١٠١٩٨١

حاصله على دبلوم تجاره



أنثى مسلمة متزوجة

حسن ابراهيم مصطفى راضي

البطاقة سارية حتى ٢٠٢٩/٠٨/١٢



Name: هند فاروق محمد سعودي		GUSTAVE ROUSSY	
MR. : 2662			
Detailed Medical Report			
			السيد
تجبة طبية وبعد,,			
		إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
		رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته			
تاريخ وساعة الدخول :		تاريخ وساعة الخروج :	
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه			
MDT 9/2022: ZOLADEX>FEMARA> IBRANCE>ZOMETA CT 10/2025:SD BONE SCAN 10/2025:SD			
last bone sca 12\1 rt breast mets to cervicolumbar vertebrae ,scrum, both sacroiliac rt ischium.			
Clinical pharmacy note : for zometa today not received 7/12/2025 new labs OK			
mbc pt is known diapetic 20/4/2026 mdt :pd for aromasine +affinitor approval paper done			
affinitor+aromasin +zometa next clinic visit :8/7/2026			
Patinet has increased pain over metastatic site (specifically SIJ) ,, For Palliative RTH over bil SIJ (previous pall RTH on dorsal vv 4 years ago) . Consider Zometa mnthly if pain persisted , Pain Clinic already on FU. for 3rd cycles Affinitor Aromasine today and Will do CT assessment after this cycle .			
pt received palliative rth to both SIJ 20gy/5f/1w from 15/8 to 19/8 ct 30/7 >> multiple osseous lesion (already present before no comparison) for new bone scan compare to last one in 4/2026 for c4 afinitor + aromasin + zoladex zometa due 1/9/2026 at pharmacy after labs			
تحريرا في ,			
		التاريخ :	19-09-2026
		الوقت :	
		الطبيب المعالج :	نهى سعيد علي محمد
يعتمد ,			

Name : HEND FAROUK MOHAMED SAADI

Date : 04-02-2026 04:01

Branch : Portable

Medical No. : GRI-12276

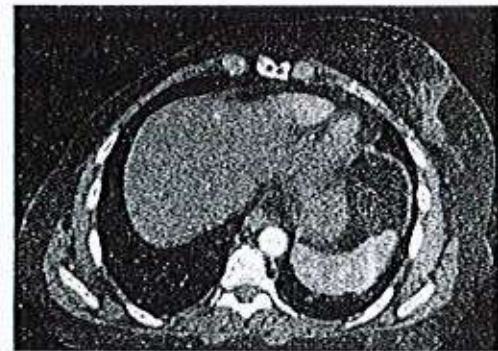
Ref.Physician Prof : CAP+C

Ins.Company :

**MULTI-DETECTOR C.T. EXAMINATION OF THE CHEST,
ABDOMEN AND PELVIS FOLLOWING ORAL AND
INTRAVENOUS CONTRAST MEDIA ADMINISTRATION
REVEALED:**

Clinical data: Managed right breast cancer with MRM as compared with previous CT the current study revealed

- Stationary course with clear right mastectomy bed with no evidence of tumor recurrence
- Left lower calyceal two stones measures 7 mm and 480 HU with no back pressure changes



Otherwise;

- Normal lung parenchyma, showing no focal lesions.
- Normal vascular mediastinal structures.
- The trachea, main stem bronchi as well as their lobar and segmental divisions are normal.
- No evidence of mediastinal or hilar nodal enlargement.
- No pleural collections.
- The liver is of normal size, and tissue density. It shows no focal or enhancing lesions.
- The intra and extra-hepatic biliary radicles are normal.
- The pancreas and spleen are normal.
- Normal CT features of right kidney.
- Right and left supra renal glands are normal.
- No CT evidence of enlarged abdominal or pelvic lymph nodes.
- No ascites.
- Scans through the pelvis showed no masses.

Opinion

- Clear right mastectomy bed with no evidence of tumor recurrence
- Left lower calyceal stone

Much Obligated;
Dr. Khaled Moghazy, MD
Prof. of Radiology

Name : Hind Farouk Mohammed Saud
Branch : Dokki
Ref.Physician Prof : Goustav Roussey Egypt

Date : 12-01-2026 11:00
Medical No. : 293317
Ins.Company : معمل مستشفى

Whole Body Bone Scintigraphy (Technetium-99m MDP)

INDICATION: 49-year-old female with history of metastatic breast cancer. Prior bone scan dated [16/04/2025] showed multifocal skeletal metastases with stationary course.

TECHNIQUE: Following intravenous administration of Technetium-99m MDP, planar anterior and posterior whole-body images were obtained approximately 3 hours post-injection.

FINDINGS:

Compared to the prior bone scan of [16/04/2025], there is interval progression of multifocal skeletal metastatic disease, manifested by both an increase in the number of lesions and an increase in the intensity of uptake in previously identified sites.

- **Newly seen osseous lesions:** small focal lesion at the right occipitoparietal aspect of the skull, as well as the sternum.
- **Old lesions showing increased number/tracer uptake intensity:** multiple cervicodorsolumbar vertebrae, sacrum, both sacroiliac articulations and right ischium.

IMPRESSION:

1. Interval progression of multiple metastatic osseous lesions as detailed, for clinical/radiological correlation.
2. Follow-up as warranted is kindly advised.

Much oblige
Dr. Alaa Nagi, MD
Nuclear medicine

Name : Hind Farouk Mohammed Saud
Branch : Dokki
Ref.Physician Prof : Goustav Roussey Egypt

Date : 12-01-2026 11:00
Medical No. : 293317
Ins.Company : شركة مستشفيات

Whole Body Bone Scintigraphy (Technetium-99m MDP)

INDICATION: 49-year-old female with history of metastatic breast cancer. Prior bone scan dated [16/04/2025] showed multifocal skeletal metastases with stationary course.

TECHNIQUE: Following intravenous administration of Technetium-99m MDP, planar anterior and posterior whole-body images were obtained approximately 3 hours post-injection.

FINDINGS:

Compared to the prior bone scan of [16/04/2025], there is interval progression of multifocal skeletal metastatic disease, manifested by both an increase in the number of lesions and an increase in the intensity of uptake in previously identified sites.

- **Newly seen osseous lesions:** small focal lesion at the right occipitoparietal aspect of the skull, as well as the sternum.
- **Old lesions showing increased number/tracer uptake intensity:** multiple cervicodorsolumbar vertebrae, sacrum, both sacroiliac articulations and right ischium.

IMPRESSION:

1. Interval progression of multiple metastatic osseous lesions as detailed, for clinical/radiological correlation.
2. Follow-up as warranted is kindly advised.

Much oblige
Dr. Alaa Nagi, MD
Nuclear medicine



Patient Name	: الأستاذ / دة المروة محمد ممدودي	Request No.	: 13009152
Patient No.	: 27701150101981	Request Date	: 30/08/2022
Path No.	: SR-640/22	Verification Date	: 19/09/2022
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 45 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :		Registered by	: marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical data: Known case of metastatic breast cancer to lung & bone presented by Right suprarenal mass.

Nature of Specimen : Slide revision (US guided biopsy from right suprarenal mass)
Gross: One block & one slide labeled as 676152.

Microscopic:

Metastatic adenocarcinoma

• IPT (Positive control showed appropriate reactivity) :

• GATA3: Positive nuclear staining

• Synaptophysin: Negative

• ER: Strong nuclear reaction in 80% of tumor cells (Allred score 8/8)

• PR: Strong nuclear reaction in 60% of tumor cells (Allred score 7/8)

• HER2: Moderate complete membrane reaction in >10% of tumor cells (score 2+)

- Average Her2 copy No.: 2.2

- Her2/ CEP17 ratio: 1.6

- SISH: Not Amplified.

Diagnosis:

Right supra-renal mass, Slide revision, Metastatic carcinoma of mammary origin.

• ER: Positive (score 8/8).

• PR: Positive (score 7/8).

• HER2: Equivocal (score 2+).

• SISH: Not Amplified.

Prof. Dr. Iman Gouda

Prof. Lobna Omar

Dr. Marwa Mahmoud

Verified by :

Printing Date : 19/09/2022 14:53:29

Page 1 of 2

Printing By : dr Enas



Presidential Initiative for Women's Health - Pathology Lab
المبادرة الرئاسية لصحة المرأة - معمل الباثولوجي

Patient Name	: الأستاذ / هاد فاروق محمد مسعودي	Request No.	: 13009152
Patient No.	: 27701150101981	Request Date	: 30/08/2022
Path No.	: SR-640/22	Verification Date	: 07/09/2022
Sex	: Female	Financial Category	: أورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 45 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :		Registered by	: marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical data: Known case of metastatic breast cancer to lung & bone presented by Right suprarenal mass.

Nature of Specimen : Slide revision (US guided biopsy from right suprarenal mass)

Gross: One block & one slide labeled as 676162.

Microscopic:
Metastatic adenocarcinoma

Diagnosis:
Metastatic adenocarcinoma for IPT; GATA3, Synaptophysin, ER, PR, HER2)

Prof. Dr. Iman Gouda
Prof. Lobna Omar
Dr. Marwa Mahmoud

د. مروة محمود

Verified by :
Dr. Marwa Mahmoud

Printing Date : 12/09/2022 13:02:57

Page 1 of 1

Printing By : Ali mostafa

مركز الباثولوجي - مستشفى دار السلام - القاهرة - مصر
Phone: 0111 2311111 - Fax: 0111 2311111 - Email: info@daraslam.gov.eg

Patient Name: Hend Farouk Mohamed Saodi

Exam : CT CAP(CT Chest Abd. Pelvis)

Medical ID: 3138/2022

Date : 08/10/2025

Age : 48 Year(s)

Pat. ID: 12276

VON CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN & PELVIS

REVEALED:

- Compared to the previous study dated 06/03/2025.

1. Chest:

- Right MRM with still no operative bed sizable mass lesions or collection.
- **No gross time interval changes** regarding:
 - Few prominent left cardio-phrenic lymph nodes.
 - Few bilateral scattered tiny pulmonary nodules.
- Otherwise, no pathological hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Average cardiac size. No pericardial effusion detected.

2. Abdomen and pelvis:

- The liver is average in size with homogenous low parenchymal attenuation (fatty liver). No definite focal lesions
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Stable right adrenal lesion measures about 2.6 x 3.8 cm.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- No pathological abdominal or pelvic lymph nodes.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no right renal stones or back-pressure changes. Still noted left renal 1.5 cm stone (current density about 1415 HU) with mild left hydrocalycosis.
- Normal appearance of the pancreas and left supra-renal gland.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.
- IUD seen in situ.
- Rather stationary wide spread axial and appendicular skeleton heterogenous sclerotic lesions & foci.

- Follow up state running rather stationary course since last study dated 06/03/2025.

OPINION:

rof. Ali Remah



MDT FORM

20 / 9 / 20 22 G

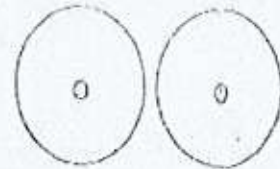
MDT FORM
2022

Name	சாந்திரா டி	MRN	2022 / 3188
Age	45 yrs	ID	21701150161981
Menopausal status	premenop	Phone	999XXXXXX
NRS SCORE	2	marital status	married
DM	obese	Family history	-ve FH
Co morbidity	DM RT MRM + CS	REASON OF MDT	

Clinical Data

Bi:	IDC II						
ER:	+	PR:	+	HER2:	-ve	Ki67:	25 %
Sonomammography: - US post operative RT MRM. Free Postop bed							
Metastasis Workup: CTs - Fu. Iliac lymph LN - Pulmo Nodules - Rt adenexal mass osseous clasp							

R



T N M

Recommendations: Adj EC II → H T adenexal b/p pending
- For AI then Progression
Plan for sec Line Treat: HT

MDT OUTCOME & PLAN

9.10.22 / Hemat / K. S. G. / 2022

CPRB/CA
SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	psychiatric
SH		Dr. S. S. S.		SSS	

20/9/2022

Anandhu